

09 - 3 L'approche clinique centrée sur le patient ACP

(0:00 - 0:54)

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous rencontrer encore une fois pour traiter ce cours sur l'approche clinique centrée sur le patient. Les objectifs de ce cours sont comparer l'approche centrée sur le patient au modèle traditionnel des soins, décrire les principes de l'approche centrée sur le patient et savoir utiliser les outils de l'approche centrée sur le patient. L'approche clinique centrée sur le patient s'appuie sur une relation de partenariat avec le patient, ses proches et le professionnel de la santé, visant à bien se représenter les problèmes de santé et comprendre le vécu du patient au regard de ces problèmes.

(0:56 - 1:28)

Cette approche s'appuie sur la relation symétrique de communication qu'on a vu dans les chapitres précédents et qui est basée sur le principe de la coopération. Il faut intégrer cette approche dans l'ensemble de la démarche de soins, du recueil des données jusqu'au suivi thérapeutique. L'approche centrée sur le patient comporte six composantes complémentaires et interreliées.

(1:30 - 1:58)

Explorer la maladie et l'expérience de la maladie vécue par le patient. Comprendre la personne dans sa globalité bio, psycho, sociale, c'est-à-dire la maladie et ses symptômes, le vécu psychologique et social. S'entendre avec le patient sur le problème, les solutions et le partage des responsabilités entre le médecin et son malade.

(1:59 - 2:20)

Valoriser la prévention et la promotion de la santé. Développer la relation patient-médecin et faire preuve de réalisme. Actuellement, toutes les études s'accordent sur l'importance de l'approche centrée sur le patient.

(2:21 - 2:46)

Alors, est-ce qu'il y avait un modèle traditionnel et quels sont ses caractéristiques ? En effet, dans le modèle traditionnel de soins, le rôle du patient est passif. Il écoute le professionnel de la santé expliquer le traitement. La prise de décision est essentiellement assurée par le professionnel de la santé qui n'offre pas d'options.

(2:48 - 3:09)

Il s'agit d'un modèle centré sur la maladie et sur les symptômes. Concernant la communication, c'est surtout le professionnel de la santé qui parle, n'accorde que très peu de temps au patient

pour poser les questions. Le plan de traitement est recommandé et fourni au patient.

(3:10 - 3:56)

Ce plan est axé sur le traitement de la maladie diagnostiquée. Quels sont les reproches qu'on a sur ce modèle traditionnel ? En effet, au cours de ces dernières décennies, ce modèle paternaliste a fait l'objet de critiques tant de la part des professionnels de la santé que de la part des patients. Les professionnels sont d'avis que ce modèle traditionnel n'est pas efficace puisque les patients ne suivent pas nécessairement les consignes du médecin, surtout dans les cas de la prévention ou dans le traitement des maladies chroniques telles le diabète.

(4:01 - 4:17)

Quels sont les principes directeurs de l'approche centrée sur le patient ? Explorer la maladie et l'expérience de la maladie. Demander l'avis du patient. A pour attente, c'est l'agenda caché du patient.

(4:18 - 4:46)

V pour vécu, émotion, représentation. I pour impact et S pour certains. Concernant les attentes du patient, il faut les clarifier par rapport au rôle du médecin, soignant, assurant la prévention, l'éducation, le suivi ou autre.

(4:47 - 5:13)

Par rapport aussi aux investigations, par rapport au traitement, ses modalités curatives ou palliatives, ses effets secondaires et autres. Il faut aussi explorer le vécu du patient au niveau émotionnel par rapport à sa maladie. Il faut explorer ses idées, ses représentations de la maladie.

(5:14 - 5:26)

Par exemple, le cancer est synonyme de mort chez beaucoup de malades. La maladie mentale est synonyme de folie. Il faut explorer aussi son vécu dans l'entourage.

(5:26 - 5:53)

Est-ce qu'il s'agit d'un entourage soutenant ou plutôt déstabilisant ? On explore l'impact de la maladie au niveau socio-professionnel. Est-ce qu'elle est cause d'absentéisme fréquent ? Et les répercussions du problème sur la vie quotidienne. C'est-à-dire, on explore l'handicap causé par la maladie.

(5:54 - 6:25)

Chez certains patients épileptiques, certains sports sont contre-indiqués. On aborde les

symptômes vraiment qu'à la fin, en termes de localisation, qualité, horaire, facteurs soulageants ou aggravants et autres. Il s'agit d'un schéma qui résume les principes de l'approche centrée sur le patient.

(6:29 - 6:56)

On va aborder maintenant le chapitre sur les stratégies de mise en œuvre de l'approche centrée sur le patient. D'abord, écoutez, partagez des informations. Comment informer ? Aussi souvent que nécessaire, il faut bien choisir le moment adéquat, vérifier si le patient désire entendre les nouvelles ou s'il souhaite attendre.

(6:58 - 7:21)

Selon quelle modalité ? L'information doit être personnalisée, hiérarchisée, compréhensible par le patient. Elle doit être cohérente, située dans la démarche des soins. Vérifier, c'est-à-dire reformuler par le patient de ce qu'il a compris et comment participer au soin.

(7:26 - 7:59)

Ensuite, la prise de décision doit être partagée entre le patient et le médecin qui présente les différents choix thérapeutiques possibles avec accord mutuel sur une option de soin. S'accorder sur l'adoption d'objectifs cliniques, biologiques, psychosociaux de changement et d'habitude de vie. S'accorder sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et aux modalités de suivi et de soutien.

(8:03 - 8:36)

Troisièmement, écouter et soutenir le patient tout au long de son parcours. Reconnaître les efforts du patient ou de ses proches et encourager les comportements bénéfiques à la santé et les soutenir. Soutenir la motivation du patient à se soigner et faciliter l'expression du patient sur ses difficultés, les analyser, les comprendre et rechercher les solutions avec le patient ou ses proches.

(8:41 - 9:05)

Il s'agit d'un tableau important qui compare le modèle de soin traditionnel par rapport à l'approche centrée sur le patient. Vous voyez que la priorité du médecin, dont le modèle de soin traditionnel, est la maladie. Tandis que dans le modèle de soin centré sur le patient, la priorité du médecin devrait être le patient.

(9:09 - 9:37)

En conclusion, dans l'approche clinique centrée sur le patient, les patients participent beaucoup plus activement aux décisions concernant leur traitement et ils sont beaucoup plus susceptibles

d'exprimer leurs besoins et leurs opinions. Le rôle important du patient à mener à une relation plus équilibrée entre le médecin et le patient, c'est le type de relation symétrique. Je vous remercie.